

■ 50代からの個別お金防衛カルテ 02 ■

医療・介護の備え 優先順位シート

重点テーマ「医療・介護の備え」と診断されたあなたへ

「安心お金の価値観・リスク診断」の結果にもとづく、あなた専用の実践シートです。

上から順に、できたところに チェック□ を入れていくだけで使えます。

■ このカルテの使い方(3ステップ)

1. 印刷するか、スマホでこのまま眺めながら進めます
2. できている項目の □ にチェックを入れます(できていなくて当たり前です)
3. チェックが入らなかった項目を、1週間に1つだけ進めてみてください

発行：50代からのお金の教科書(2026年7月時点)

STEP 1 「公的保障の実力」を先に知る

民間保険を考えるのは、公的保障を知ってからが正しい順番です。日本の公的保障は意外なほど手厚いのです。

☐ 高額療養費制度を知っている

医療費の自己負担には月ごとの上限があります。たとえば70歳未満・年収370～770万円なら月9万円弱が目安(収入により異なります)。

☐ 限度額適用認定証(またはマイナ保険証)を知っている

事前の手続きで、窓口での支払い自体を上限額までにできます。マイナ保険証なら手続き不要になる場合もあります。

☐ 医療費控除を知っている

家族分を合算して年10万円(または所得の5%)を超えた分は、確定申告で税金が戻ります。レシートは捨てずに保管を。

STEP 2 「介護の入り口」を知っておく

介護は突然始まります。いざという時に慌てないための3つです。

☐ 地域包括支援センターの場所を調べた

介護の総合相談窓口です。「親のことで…」という漠然とした相談でもOK。お住まいの市区町村名+地域包括支援センターで検索できます。

☐ 介護保険の申請の流れを知っている

市区町村に申請 → 認定調査 → 要介護度の決定 → ケアプラン作成、という流れです。申請は家族が代行できます。

☐ 介護サービスの自己負担割合を知っている

原則1割負担(所得により2～3割)。さらに高額介護サービス費という月額上限のしくみもあります。

STEP 3 いまの保険を「棚卸し」する

新しく入る前に、いま入っている保険の整理から。ここで払いすぎが見つかる方がとても多いです。

☐ 加入中の保険証券を1か所に集めた

生命保険・医療保険・がん保険・共済…。まず全部を1つの引き出しやファイルにまとめるだけで大きな前進です。

☐ 保障内容の重複をチェックした

入院日額の合計はいくらか。STEP1の公的保障と重なりすぎていないか。「なんとなく2つ入っている」は見直しどころです。

☐ 保険料の合計月額を書き出した

全部でいくら払っているかを1つの数字に。年間・10年間に直してみると、見直しの本気度が変わります。

STEP 4 足りない分「だけ」民間で備える

順番の最後が民間保険です。「不安だから」ではなく「この金額が足りないから」で選ぶのがコツです。

☐ 公的保障でカバーされない費用を確認した

差額ベッド代・先進医療・入院中の食事代・交通費などは高額療養費の対象外です。ここが民間保険の出番です。

☐ 家族に保険と医療情報の場所を伝えた

保険の一覧・かかりつけ医・お薬手帳の場所を家族と共有。いざという時、請求もれを防ぎます。

■ 次の一歩

■ 最初の一歩はSTEP1から

今週は「高額療養費制度で自分の上限額を調べる」だけでOKです。ご自身の健康保険組合（または協会けんぽ・国保）のサイトで確認できます。くわしい解説は『50代からのお金の教科書』の保険・制度カテゴリの記事でお読みいただけます。

■ 相談できる公式の窓口

- ・ ご加入の健康保険組合/協会けんぽ/市区町村の国保窓口
- ・ 地域包括支援センター（介護の総合相談）
- ・ 市区町村の介護保険課
- ・ 国税庁（医療費控除/確定申告）

【ご注意】本資料は2026年7月時点の一般的な情報にもとづく情報提供を目的としたもので、個別の投資助言・保険募集・税務助言ではありません。制度の内容は法改正等により変更される場合があります。実際の手続きやご判断の際は、必ず公式の窓口や専門家にご確認ください。